Блок безопасности: Колумбийская шкала серьёзности суицидальных намерений (C-SSRS)

Источник: приложение Г4 клинических рекомендаций по депрессии (Posner K. et al., Am J Psychiatry 2011;168(12):1266-77). **Назначение:** оценка тяжести суицидальных мыслей и риска. В рекомендациях это шкала для интервью врача.

Как использовать на сайте. Пациенту показываем вопросы 1–5 и вопрос о подготовительных действиях и поведении, ответы «да» или «нет». Полную шкалу с интенсивностью идей и описанием поведения заполняет врач. Такое сокращение для пациента нужно подтвердить у куратора и в источнике правообладателя.

Суицидальные идеи (ответы «да» или «нет»)

Порядок: задать вопросы 1 и 2. Если на оба ответ «нет», перейти к разделу о поведении. Если на вопрос 2 ответ «да», задать вопросы 3, 4 и 5.

№	Вопрос пациенту	Ответы
1	Возникало ли у Вас желание умереть или заснуть и не просыпаться?	да / нет
2	Думали ли Вы, в самом деле, о том, чтобы убить себя?	да / нет
3	Думали ли Вы о том, как Вы могли бы это сделать?	да / нет
4	Посещали ли Вас подобные мысли, и было ли у Вас какое-нибудь намерение действовать в соответствии с ними?	да / нет
5	Начали ли Вы разрабатывать или уже разработали детальный план самоубийства? Намереваетесь ли Вы осуществить этот план?	да / нет

Суицидальное поведение (ответы «да» или «нет»)

Вид	Вопрос пациенту	Ответы
Истинная попытка	Предпринимали ли Вы попытку самоубийства? Предпринимали ли Вы какие-либо опасные действия, которые могли привести к Вашей смерти?	да / нет
Прерванная попытка	Случалось ли, что когда Вы начинали совершать какие-либо действия с целью	да / нет

	покончить с собой, кто-то или что-то останавливал Вас прежде, чем Вы фактически совершали что-либо?	
Остановленная попытка	Случалось ли, что когда Вы начинали совершать какие-либо действия с целью покончить с собой, Вы останавливали себя сами прежде, чем фактически совершали что-либо?	да / нет
Подготовительные действия	Предпринимали ли Вы какие-либо шаги с целью осуществить попытку самоубийства или приготовиться к самоубийству (например, приобретали таблетки, оружие, раздавали ценные вещи или писали предсмертную записку)?	да / нет

Интенсивность идей (заполняет врач)

Эти пять характеристик оцениваются по самой сильной идее, каждая по шкале от 1 до 5:

Характеристика	**Варианты ответа (от меньшего к большему)**
Частота	реже одного раза в неделю; раз в неделю; 2–5 раз в неделю; каждый день или почти каждый день; многократно каждый день
Продолжительность	мимолётны (секунды или минуты); менее часа; 1–4 часа; 4–8 часов; более 8 часов или постоянны
Контролируемость	с лёгкостью контролирует; с незначительными затруднениями; с некоторыми затруднениями; с большими затруднениями; не в состоянии контролировать; не пытается контролировать
Сдерживающие факторы	определённо удержали; вероятно удержали; не уверен; скорее всего не удержали; определённо не удержали; не применимо
Основания	исключительно привлечь внимание или отомстить; большей частью для этого; в равной степени и чтобы прекратить боль; большей частью чтобы прекратить боль; исключительно чтобы прекратить боль; не применимо

Как интерпретировать (ключ из рекомендации)

- **Тяжесть идей:** это номер самого высокого вопроса из 1–5, на который получен ответ «да» (такое прочтение стандартной схемы шкалы нужно сверить с материалами правообладателя).
- **3 балла и выше** означает серьёзный риск суицида.
- **5 баллов, а также любые выявленные суицидальные действия** означают крайне высокий риск и абсолютную необходимость ургентных терапевтических мероприятий и госпитализации.
- Раздел интенсивности позволяет точнее оценить тяжесть и спрогнозировать динамику.

Что делает система

Результат	Действие
Ответы «нет» на всё	Продолжить опросники, спросить снова при следующем заполнении.
Да на 1 или 2, но не выше	Флаг врачу «суицидальные мысли», предложить полную шкалу, пациенту показать контакты помощи.
Да на 3, 4	Серьёзный риск: срочный алерт врачу, контакты экстренной помощи пациенту.
Да на 5 или любое поведение	Экстренно: алерт врачу и эскалация, остальные опросники откладываются.

Депрессия

Для пациента: PHQ-9 (решение команды, в клинических рекомендациях его нет)

Важно. В ваших рекомендациях по депрессии названы только врачебные шкалы (HDRS, MADRS). PHQ-9 мы берём как пациентский скрининг по решению команды. Формулировки ниже — рабочий перевод стандартной версии шкалы; перед запуском замените их на валидированную русскую версию и проверьте условия использования.

Инструкция: Как часто за последние 2 недели Вас беспокоили следующие проблемы? Варианты ответа для всех пунктов: **Никогда = 0; Несколько дней = 1; Более половины дней = 2; Почти каждый день = 3.**

№	Пункт
1	Мало интереса или удовольствия от дел
2	Плохое настроение, подавленность или безнадёжность
3	Трудности с засыпанием или сон прерывистый, либо чрезмерная сонливость
4	Усталость или нехватка энергии
5	Плохой аппетит или переедание
6	Ощущение, что вы неудачник или подвели себя или свою семью
7	Трудности с концентрацией (например, при чтении или просмотре телевизора)

8	Движения или речь настолько замедлены, что окружающие могли это заметить; или, наоборот, вы настолько беспокойны, что двигаетесь гораздо больше обычного
9	Мысли о том, что лучше бы вам умереть, или о том, чтобы причинить себе вред

Интерпретация. Сумма от 0 до 27.

Сумма	**Выраженность симптомов**
0–4	Минимальная
5–9	Лёгкая
10–14	Умеренная
15–19	Умеренно тяжёлая
20–27	Тяжёлая

Ответ на пункт 9 выше 0 всегда запускает блок безопасности (C-SSRS) и алерт врачу, если передача разрешена. Сумма 10 и выше считается значимой для скрининга по исходной валидации шкалы. Диагноз шкала не ставит.

Для врача: шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберг (MADRS)

Источник: приложение Г2 клинических рекомендаций (Montgomery S.A., Åsberg M., Br J Psychiatry 1979;134:382-9). **Назначение:** количественная оценка тяжести депрессии до, во время и после лечения. Заполняет врач по клиническому интервью, около 20–25 минут. Врач выбирает основное значение 0, 2, 4 или 6 или промежуточное 1, 3, 5. Каждый пункт оценивается от 0 до 6, сумма от 0 до 60.

№ и пункт	**0 баллов**	**2 балла**	**4 балла**	**6 баллов**
1. Объективные признаки пониженного настроения (в речи, мимике, позе)	Подавленность отсутствует	Выглядит подавленным, но легко оживляется	Выглядит печальным и несчастным большую часть времени	Постоянно выглядит угнетённым, чрезвычайно подавлен
2. Субъективные признаки подавленности (сообщаемое настроение)	Эпизодическая подавленность, связанная с обстоятельствами	Печален или подавлен, но легко отвлекается	Глубокое чувство угнетённости или уныния; настроение ещё подвержено влиянию внешних обстоятельств	Постоянное и неизменное чувство подавленности, отчаяния и угнетённости
3. Внутреннее напряжение	Спокоен; лишь мимолётное внутреннее напряжение	Эпизодически испытывает раздражение и ощущение	Стойкое чувство внутренней напряжённости или	Неослабевающий страх или душевная боль; непреодолимая

		болезненного дискомфорта	эпизодическая паника, которая требует усилий для её преодоления	паника
4. Нарушения сна	Сон не нарушен	Незначительное затруднение засыпания или несколько укороченный, поверхностный или прерывистый сон	Сон укорочен не менее чем на 2 часа	Продолжительность сна менее 2–3 часов
5. Снижение аппетита	Нормальный или повышенный аппетит	Несколько сниженный аппетит	Отсутствие аппетита, пища не имеет вкуса	Необходимо принуждение для приёма пищи
6. Нарушения концентрации внимания	Нет трудностей концентрации	Эпизодически трудно собраться с мыслями	Затруднения концентрации и длительного сосредоточения, снижение способности читать или вести беседу	Утрата способности читать или вести беседу без значительных усилий
7. Усталость (затруднения начать деятельность, замедленность)	Трудности в начале деятельности сомнительны, замедленности нет	Затруднение начать активную деятельность	Трудности начать рутинные действия, сопряжённые с затратой сил	Сильная вялость, неспособность делать хоть что-нибудь без помощи
8. Неспособность испытывать чувства	Нормальный интерес к окружающему и людям	Снижение способности получать удовольствие от обычных интересов	Утрата интереса к окружающему, утрата чувств к друзьям и близким	Явления эмоционального паралича, неспособность испытывать гнев, горе или удовольствие
9. Пессимистические мысли	Отсутствие пессимистических мыслей	Эпизодические мысли о собственной неспособности добиваться успеха, самоупреки и самоунижение	Постоянное самообвинение или конкретные, но ещё сохраняющие рациональность идеи вины или греха; нарастающая пессимистическая оценка	Бредовые идеи полного краха, раскаяния или неискупаемого греха; абсурдное и непоколебимое самообвинение

			будущего	
10. Суицидальные мысли	Доволен жизнью или принимает её такой, какая она есть	Усталость от жизни; лишь мимолётные суицидальные мысли	Возможно, лучше было бы умереть; суицидальные мысли становятся привычными, самоубийство рассматривается как возможный способ решения проблем при отсутствии конкретных планов	Конкретное планирование самоубийства при первой возможности; активные приготовления

Интерпретация (ключ из рекомендации).

Сумма	**Тяжесть**
0–6	Норма
7–19	Лёгкое депрессивное расстройство
20–34	Депрессивное расстройство средней степени тяжести
более 34	Депрессивное расстройство тяжёлой степени

Для динамики: ремиссия — менее 10 баллов, ответ на терапию — снижение на 50%. Пункт 10 (суицидальные мысли) с оценкой 2 и выше запускает полную C-SSRS, 4 и выше даёт срочный алерт (это порог команды, в рекомендациях его нет).

Тревога

Для пациента: скрининговый опросник ГТР-7 (GAD-7)

Источник: приложение Г2 рекомендаций по ГТР (Spitzer R.L. et al., 2006; русская адаптация: Золотарева А.А., Консультативная психология и психотерапия, 2023, т. 31, № 4, с. 31–46). Рекомендация по применению: «при необходимости скрининга», уровень убедительности B, достоверности 3.

Инструкция: Как часто за последние 2 недели Вас беспокоили следующие проблемы? Варианты ответа: **Никогда = 0; Несколько дней = 1; Более половины дней = 2; Почти каждый день = 3.**

№	**Пункт**
1	Повышенная нервная возбудимость, беспокойство и раздражительность
2	Неспособность справиться с волнением
3	Чрезмерное беспокойство по разным

	поводам
4	Неспособность расслабиться
5	Крайняя степень беспокойства: «не могу найти себе место»
6	Легко поддаюсь чувству беспокойства или раздражительности
7	Опасение чего-то страшного

Интерпретация. Сумма по всем 7 вопросам, от 0 до 21.

Сумма	**Уровень тревожности**
0–4	Минимальный
5–9	Умеренный
10–14	Средний
15–21	Высокий

Пояснение из рекомендации: инструмент скрининговый и требует дальнейшей клинической диагностики. Для диагноза ГТР рекомендации также требуют устойчивой и трудно контролируемой тревоги не менее 6 месяцев, поэтому после опросника стоит задать дополнительный вопрос: «Как давно у Вас есть такое беспокойство?» (вопрос добавлен мной по смыслу рекомендации, в шкале его нет).

Для врача: шкала Гамильтона для оценки тревоги (HARS)

Источник: приложение Г1 рекомендаций по ГТР (Hamilton M., Br J Med Psychol 1959;32:50–55). Клиническая рейтинговая шкала для специалистов: заполняется по полуструктурированному интервью (20–30 минут). Пациенту шкалу не предъявлять и прямых вопросов по пунктам не задавать. 14 пунктов, каждый оценивается от 0 до 4: **0 = отсутствует; 1 = в слабой степени; 2 = в умеренной; 3 = в тяжелой; 4 = в очень тяжелой степени.**

№	**Пункт и что входит в оценку**	**Сфера**
1	Тревожное настроение: озабоченность, ожидание наихудшего, тревожные опасения, раздражительность	психика
2	Напряжение: ощущение напряжения, вздрагивание, легко возникающая плаксивость, дрожь, чувство беспокойства, неспособность расслабиться	психика
3	Страхи: боязнь тёмноты, незнакомых людей, животных, транспорта, толпы, страх оставаться одному	психика

4	Инсомния: затрудненное засыпание, прерывистый сон, сон, не приносящий отдыха, кошмарные сновидения	психика
5	Интеллектуальные нарушения: затрудненная концентрация внимания, ухудшение памяти	психика
6	Депрессивное настроение: утрата привычных интересов, подавленность, ранние пробуждения, суточные колебания состояния	психика
7	Соматические симптомы (мышечные): боли, подергивания, напряжение, скрипение зубами, срывающийся голос, повышенный мышечный тонус	соматика
8	Соматические симптомы (сенсорные): звон в ушах, нечёткость зрения, приливы жара или холода, слабость, покалывание	соматика
9	Сердечно-сосудистые симптомы: тахикардия, сердцебиение, боль в груди, пульсация в сосудах, чувство слабости, частые вздыхи, диспноэ	соматика
10	Дыхательные симптомы: чувство давления или сжатия грудной клетки, ощущение удушья, частые вздыхи, диспноэ	соматика
11	Гастроинтестинальные симптомы: затрудненное глотание, метеоризм, боль в животе, изжога, тошнота, рвота, диарея, снижение веса, запоры	соматика
12	Мочеполовые симптомы: учащённое или сильные позывы на мочеиспускание, нарушения цикла, снижение либидо и прочее	соматика
13	Вегетативные симптомы: сухость во рту, покраснение	соматика

	или бледность кожи, повышенное потоотделение, головные боли напряжения	
14	Поведение при осмотре: ерзанье на месте, беспокойная жестикуляция или ходьба, тремор рук, нахмуривание бровей, напряжённое выражение лица, вздыхи или учащённое дыхание, бледность лица	осмотр

Интерпретация. Общий балл — сумма по всем пунктам (максимум 56). Пункты 1–6 можно оценить отдельно как тревогу в психической сфере, пункты 7–14 — в соматической.

Сумма	**Значение**
0–7	Отсутствие тревоги
8–17	Наличие симптомов тревожного расстройства
18–24	Средняя выраженность
25–56	Тяжёлая степень выраженности

Для динамики: ремиссия — менее 7 баллов, ответ на терапию — снижение более чем на 50% (раздел терапии ГТР).

Паника

Для пациента, шаг 1: скрининговый опросник для выявления панических атак

Источник: приложение Г3 рекомендаций по паническому расстройству (Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B. et al., JAMA 1999;282:1737-44). Самоотчёт пациента. Все ответы «да» или «нет».

Вопрос 1. Наличие приступов тревоги:

Пункт	**Вопрос**
1a	Испытывали ли вы приступы (атаки) внезапной тревоги, страха или ужаса в течение последних 4 месяцев? (при ответе «да» продолжить)
1b	Были ли у вас подобные приступы когда-нибудь прежде?
1c	Возникают ли некоторые из этих приступов неожиданно, вне связи с определённой ситуацией, где вы ощущали бы беспокойство или дискомфорт?
1d	Есть ли у вас боязнь приступа или его последствий?

Вопрос 2. Во время вашего последнего приступа вы испытывали:

Пункт	Ощущение
2a	Поверхностное, учащённое дыхание
2b	Сердцебиение, пульсацию, перебои в работе сердца или ощущение его остановки
2c	Боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки
2d	Потливость
2e	Ощущение нехватки воздуха, одышку
2f	Волны жара или холода
2g	Тошноту, дискомфорт в желудке, понос или позывы к нему
2h	Головокружение, неустойчивость, туман в голове или предобморочное состояние
2i	Покалывание или онемение в теле или конечностях
2j	Дрожание в теле или конечностях, подергивания или стягивание тела
2k	Страх смерти или необратимых последствий приступа

Интерпретация (ключ из рекомендации). Если на вопросы 1a–1d ответ «да» и на любые 4 вопроса из 2a–2k тоже «да», можно предполагать наличие панического расстройства. Чувствительность метода 81%, специфичность 99%. Инструмент скрининговый и требует клинической диагностики. Для сайта предлагаю добавить подсказку при ответе «да» на 2b или 2c: боль в груди и перебои в сердце требуют очного осмотра врача, чтобы исключить соматические причины (решение команды, в шкале её нет).

Для пациента и врача, шаг 2: шкала оценки тяжести панического расстройства (PDSS)

Источник: приложение Г2 (Shear M.K. et al., Am J Psychiatry 1997;154:1571–1575; адаптация Федотов И.А., 2022). Есть две версии: самоотчёт пациента (5–7 минут) и клиническая для врача. Период оценки: последние 7 дней. 7 пунктов, каждый от 0 до 4, сумма от 0 до 28. Ответы подробные, поэтому в таблице даны коротко; полная формулировка и варианты ответов берутся из приложения Г2 рекомендации.

Пояснение для пациента: паническая атака — это внезапный приступ страха или дискомфорта длительностью от 10 до 60 минут (редко несколько часов), сопровождаемый 4 и более симптомами из списка (сердцебиение, потливость, тошнота, боль в груди, головокружение, страх сойти с ума или потерять контроль, одышка, онемение или покалывание, чувство удушья, страх смерти, озноб или покраснение, чувство нереальности). Если симптомов меньше 4, это неразвёрнутая атака. Если на прошлой неделе описываемых ситуаций не было, отвечать, как если бы они были и всё было как всегда.

№	Вопрос (за последние 7 дней)	Ответы: 0 / 1 / 2 / 3 / 4

1	Сколько развёрнутых или неразвёрнутых панических атак было (частота)	0 не было; 1 ни одной развёрнутой и не более 1 неразвёрнутой в сутки; 2 до 1–2 развёрнутых в сутки или много неразвёрнутых; 3 более 2 развёрнутых за неделю, но не более 1 в день в среднем; 4 развёрнутые более 1 раза в день большую часть дней
2	Насколько сильный дискомфорт причинили атаки в момент появления	0 совсем не мешали или не было; 1 слабый; 2 средний (сильный, но можно справиться); 3 серьёзный (очень интенсивный); 4 экстремальный дистресс во время всех атак
3	Как часто и насколько сильно волновались по поводу того, когда случится следующая атака (ожидательная тревога)	0 не было; 1 эпизодическое или слабое; 2 частое или средней тяжести; 3 очень часто или в сильной степени; 4 почти постоянно или «парализующей» силы
4	Ситуации или места (общественный транспорт, кинотеатры, мосты, туннели, гипермаркеты, одиночество), которых вы избегали или боялись из-за страха панической атаки (фобическое избегание)	0 не было; 1 слабо, справлялся; 2 средне, ощутимо, но контролируемо; 3 тяжело, обширное избегание; 4 экстремально, повсеместное дезадаптирующее
5	Деятельность (упражнения, горячий душ, кофе, фильмы ужасов), которую вы избегали из-за ощущений, похожих на паническую атаку (избегание физических ощущений)	0 не было; 1 слабо; 2 средне, ограниченно; 3 тяжело, обширное; 4 экстремально, повсеместное дезадаптирующее
6	Как часто симптомы мешали работоспособности и домашним делам	0 нет влияния; 1 слабое; 2 значительное, но справлялся; 3 существенные нарушения; 4 экстремальные, выводящие из строя
7	Как часто атаки и беспокойство о них мешали социальной жизни	0 не было влияния; 1 слабое; 2 значимое, но важные дела сделаны; 3 существенное, многие планы не реализованы; 4 экстремальные, выводящие

		из строя

Интерпретация. Сумма по 7 пунктам, от 0 до 28. **9 баллов и выше указывает на необходимость формальной диагностической оценки.** Тяжесть симптомов:

Паническое расстройство	**Норма**	**Легкая**	**Умеренная**	**Тяжёлая**	**Очень тяжёлая**
Без агорафобии	0–1	2–5	6–9	10–13	14–28
С агорафобией	0–2	3–7	8–10	11–16	16–28 (в источнике границы 11–16 и 16–28 пересекаются, уточните у куратора)

Для начала можно показывать пациенту только сумму и совет, а таблицу тяжести оставить врачу, потому что она зависит от наличия агорафобии, которую устанавливает врач.

Фобии: социальная тревожность (LSAS)

Источник: приложение Г16 рекомендаций по тревожно-фобическим расстройствам (Liebowitz M.R., 1987; русская апробация: Григорьева И.В., Ениколопов С.Н., Национальный психологический журнал, 2016, №1). Самоотчёт, 24 ситуации. Период оценки: последняя неделя. Для каждой ситуации даются две оценки: страх или тревога и избегание.

Шкала страха или тревоги: 1 отсутствует; 2 выражены слабо; 3 выражены умеренно; 4 выражены сильно.

Шкала избегания: 1 никогда; 2 иногда; 3 часто; 4 как правило.

№	**Ситуация**
1	Говорить по телефону в общественных местах
2	Участвовать в деятельности небольшой группы
3	Есть в общественных местах
4	Пить в общественных местах
5	Говорить с начальством (вышестоящим лицом)
6	Выполнять какие-либо действия или говорить перед аудиторией
7	Участвовать в вечеринке, идти в гости
8	Работать под наблюдением (в присутствии) кого-либо
9	Писать под наблюдением (в присутствии) кого-либо

10	Говорить по телефону с малознакомым человеком
11	Говорить с глазу на глаз с малознакомым человеком
12	Встречаться с незнакомыми людьми
13	Мочиться в общественном туалете
14	Входить в комнату, где уже сидят другие люди
15	Быть в центре внимания
16	Выступать на собрании без подготовки
17	Тестироваться на умения, способности, знания
18	Выражать неодобрение или несогласие с малознакомым человеком
19	Смотреть прямо в глаза малознакомому человеку
20	Выступать с подготовленной речью перед группой людей
21	Пытаться познакомиться с кем-то с целью сексуальных или романтических отношений
22	Возвратить товар в магазин или договориться о выплате компенсации
23	Организовать вечеринку или пригласить гостей
24	Устоять перед настойчивыми предложениями продавца

Подсчёт. Суммируются баллы в двух столбцах (страх и избегание). Есть четыре подшкалы: страх при взаимодействии, страх при выступлении (когда на тебя смотрят), избегание взаимодействия, избегание выступления. Какие пункты к какой подшкале относятся, в рекомендации не расписано.

Интерпретация (ключ из рекомендации).

Общая сумма	**Результат**
55–65	Слабо выраженная социофобия
65–80	Достаточно выраженная социофобия
80–95	Сильная социофобия
более 95	Очень сильная социофобия

Что уточнить у куратора или в первоисточнике. В тексте рекомендации написано, что баллы идут от 0 до 3, а в самом бланке от 1 до 4. Границы ключа (55–95) близки к принятым в литературе для шкалы 0–3. Прежде чем записывать пороги в код, выберите одну шкалу и проверьте её по оригинальной публикации. Границы 65 и 80 в ключе встречаются дважды, это надо решить явно (например, «до 65 включительно»).

Травма и ПТСР: TSQ и IES-R

Шаг 1 для пациента: скрининг ПТСР (TSQ)

Источник: приложение Г1 рекомендаций по ПТСР (Brewin C.R. et al., Br J Psychiatry 2002;181:158-162). Самоотчёт, 10 вопросов, ответы «да» или «нет». Вводная фраза: «Анкета связана с вашими реакциями на травматическое событие. Ответьте „Да“, если вы испытывали симптом по крайней мере дважды на прошлой неделе».

№	Утверждение
1	Тяжёлые мысли или воспоминания о событии приходили мне в голову против моей воли
2	Мне снились тяжёлые сны о том, что со мной случилось
3	Я вдруг замечал(а), что действую и чувствую себя так, как будто ситуация повторяется снова
4	Когда что-то напоминает мне об этом событии, я чувствую себя подавленным
5	Когда что-то напоминало мне о случившемся, я испытывал(а) неприятные физические ощущения (потливость, сбой дыхания, тошноту, учащение пульса и др.)
6	У меня нарушен сон (трудности засыпания или частые пробуждения)
7	Я чувствовал(а) постоянное раздражение и гнев
8	Мне было сложно сосредоточиться
9	Я стал более осведомлён о потенциальных опасностях для себя и других
10	Я всё время был(а) напряжён(а) и вздрагивал(а), если что-то внезапно пугало меня

Интерпретация. Каждое «да» один балл. Пункты 1–5 отражают вторжение, 6–10 возбуждение. **6 баллов и больше: группа риска по ПТСР**, нужна консультация специалиста. Это скрининг: диагноз и подтверждение симптомов требуют клинического интервью и дополнительных методик.

Шаг 2: шкала оценки влияния травматического события (IES-R)

Источник: приложение Г4 (Horowitz M.J., Wilner N., Alvarez W., 1979; русская версия: Тарабрина Н.В., 2001). Самоотчёт, 22 пункта, период оценки последняя неделя. Ответы: никогда = 0, редко = 1, иногда = 3, часто = 5. Все пункты прямые.

№	Утверждение	Подшкала
1	Любое напоминание об этом событии заставляло меня	Вторжение

	заново переживать всё случившееся	
2	Я не мог спокойно спать по ночам	Вторжение
3	Некоторые вещи заставляли меня всё время думать о том, что со мной случилось	Вторжение
4	Я чувствовал постоянное раздражение и гнев	Возбудимость
5	Я не позволял себе расстраиваться, когда думал об этом событии или что-то напоминало мне о нём	Избегание
6	Я думал о случившемся против своей воли	Вторжение
7	Мне казалось, что всего случившегося как будто не было на самом деле, или всё, что тогда происходило, было нереальным	Избегание
8	Я старался избегать всего, что напоминало мне о случившемся	Избегание
9	Отдельные картины случившегося внезапно возникали в сознании	Вторжение
10	Я был всё время напряжён и сильно вздрагивал, если что-то внезапно пугало меня	Возбудимость
11	Я старался не думать о случившемся	Избегание
12	Я понимал, что меня до сих пор переполняют тяжёлые переживания по поводу случившегося, но ничего не делал, чтобы их избежать	Избегание
13	Я чувствовал что-то вроде оцепенения, и все мои переживания были как будто парализованы	Избегание
14	Я вдруг замечал, что действую или чувствую себя так, как будто всё ещё нахожусь в этой ситуации	Возбудимость
15	Мне было трудно заснуть	Возбудимость
16	Меня захлёстывали непереносимо тяжёлые переживания, связанные с той ситуацией	Вторжение

17	Я старался вытеснить случившееся из памяти	Избегание
18	Мне было трудно сосредоточить внимание на чём-либо	Возбудимость
19	Когда что-то напоминало мне о случившемся, я испытывал неприятные физические ощущения: потел, дыхание сбивалось, начинало тошнить, учащался пульс	Возбудимость
20	Мне снились тяжёлые сны о том, что со мной случилось	Вторжение
21	Я был постоянно насторожен и всё время ожидал, что случится что-то плохое	Возбудимость
22	Я старался ни с кем не говорить о случившемся	Избегание

Подсчёт. Вторжение: пункты 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20. Избегание: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22. Физиологическая возбудимость: 4, 10, 14, 15, 18, 19, 21. Баллы суммируются по каждой подшкале. **Пороговых значений в рекомендации нет**, она даёт только ключ подшкал. Для сайта показывайте три подсуммы и динамику между заполнениями, а пороги (если нужны) берите из публикации Тарабриной и согласуйте с куратором.

Для врача: для оценки в динамике и уточнения диагноза в рекомендации также приведены CAPS (клиническое интервью) и Миссисипская шкала. Их мы в первую версию сайта не включаем.

Для врача: общая клиническая оценка (CGI)

Источник: приложение Г19 рекомендаций по тревожно-фобическим расстройствам (Guy W., ECDEU Assessment Manual, 1976). Заполняет только врач после оценки по другим шкалам, в начале лечения и в конце этапа.

1. Тяжесть расстройства сейчас (CGI-S). Врач выбирает по своему клиническому опыту: 0 не поддаётся оценке; 1 здоров; 2 пограничено между нормой и расстройством; 3 лёгкое; 4 умеренно выраженное; 5 выраженное; 6 тяжёлое; 7 очень тяжёлое. (В тексте рекомендации в списке пропущен пункт 1, но ключ говорит, что шкала тяжести идёт от 1 «здоров».)

2. Общее улучшение по сравнению с исходным (CGI-C). 0 не поддаётся оценке; 1 очень сильно улучшилось; 2 сильно улучшилось; 3 минимальное улучшение; 4 без изменений; 5 минимальное ухудшение; 6 сильно ухудшилось; 7 очень сильно ухудшилось.

3. Индекс эффективности. Оценивается только эффект лекарства. Врач сопоставляет терапевтический эффект (значимый, умеренный, минимальный, без изменений или

ухудшение) с побочными эффектами (нет, не влияют на функции, влияют) и записывает число 1–16 из таблицы на пересечении.